

PITYRIASIS VERSICOLOR

Pr B FAYE

Introduction

- **Définition**

- Le Pityriasis versicolor est une mycose superficielle (épidermomycose stricte) universelle bénigne, qui siège préférentiellement dans les zones cutanées les plus riches en glandes sébacées.
- Fréquente, il touche les deux sexes et prédomine chez les sujets jeunes.
- *Malassezia furfur*, son agent pathogène, est une levure commensale de la peau, lipophile et kératinophile qui devient pathogène sous l'influence de facteurs favorissants :
 - la chaleur et l'humidité,
 - un terrain génétiquement prédisposé.
- Un traitement local est en général suffisant mais le risque de rechute demeure un problème majeur.

Epidémiologie

Agent pathogène

- *Malassezia furfur* est la seule levure de la peau qui fait partie de la flore résidente normale commensale de tout être humain.
- Son habitat naturel est essentiellement le follicule pilo-sébacé.
- Elle est dite lipophile car sa croissance nécessite la présence d'acides gras libres.
- Cela explique que la colonisation du tégument augmente dans la période pubertaire.
- La prévalence diminue chez le sujet âgé lorsque la production de sébum baisse.
- La maladie est due à la transformation de cette levure dimorphique d'une phase levure saprophyte en une phase filamenteuse pathogène
- Les filaments envahissent le stratum corneum à la fois entre et dans les cornéocytes : il en résulte des lésions cliniquement visibles.

Epidémiologie

Répartition géographique

- Le Pityriasis versicolor est une mycose cosmopolite parmi les plus fréquentes.
- Son incidence varie d'un pays à l'autre, essentiellement en fonction des données climatiques : elle ne peut être évaluée avec précision car il s'agit d'une dermatose peu gênante, passant souvent inaperçue, pour laquelle il existe peu de données statistiques.
- La fréquence varie de 0,5 %, ou moins, dans les pays nordiques à 50 % dans les régions tropicales du total des dermatoses. Ces chiffres en dessous de la réalité.

Epidémiologie

Facteurs favorisants

- les lipides cutanés jouent sûrement un rôle dans la croissance de la levure
- la sécrétion sudorale : Les zones sèches de la peau sont moins atteintes.
- La maladie se développe plus durant la saison chaude
 - Dans les régions tropicales ou subtropicales, chaudes et humides, l'infection est si fréquente qu'un nom spécifique lui est attribuée (" lotta " aux Antilles, " lotto " en RDC, "kham" au Sénégal).
- Hypercorticisme,
- Prédisposition génétique
- Comportement : échange de sous vêtement, de drap
- Promiscuité.

Clinique

- La lésion élémentaire est une macule arrondie, à limites nettes, de quelques millimètres de diamètre.
- Elle débute autour d'un follicule pileux et grandit de façon centrifuge.
- La confluence des macules réalise des lésions de taille variable allant d'un aspect en goutte à de grandes nappes à contours polycycliques.
- Au début, la teinte varie du rose-chamois au brun café au lait foncé. Puis, après un certain temps d'évolution, les lésions deviennent achromatiques et sont particulièrement inesthétiques.

Clinique

- Les lésions actives sont toujours finement squameuses, mais cette desquamation n'apparaît souvent qu'après grattage (signe du copeau).
- L'atteinte siège préférentiellement dans les zones cutanées les plus riches en glandes sébacées
 - partie haute du tronc, cou, bras, région sous-mammaire.
 - la face, la partie basse du tronc, le dos des mains, les membres inférieurs sont parfois touchés.
- Seules les paumes et les plantes sont toujours indemnes
- En dehors du caractère inesthétique, la maladie est le plus souvent asymptomatique.

Clinique

- On peut cependant noter dans certains cas,
 - un prurit
 - des atteintes folliculaires diffuses qui se traduisent par la présence de minuscules macules de 2 mm de diamètre entourant l'orifice d'un très grand nombre de follicules pileux du tronc et parfois des membres.



Pityriasis versicolor



Diagnostic

- Examen en lumière ultra-violette avec une lampe de Wood
 - révèle une fluorescence pâle jaune-verdâtre, dorée pour le pityriasis versicolor actif non traité
 - permet d'apprécier l'étendue des lésions, parfois sous-estimées à l'oeil nu.

Diagnostic

- la méthode du “ scotch test ” :
 - l’application du ruban adhésif transparent sur les lésions préalablement grattées permet de visualiser le champignon au microscope sous la forme de levures en “bouteille” regroupées en grappes et des filaments courts à paroi épaisse.
- L’examen au microscope des squames obtenues par grattage, placées entre lame et lamelle dans une goutte de potasse à 30 ou 40 %, ou dans du noir chlorazol met en évidence les mêmes éléments.

Traitement

- **primo-infection localisée :**
 - traitement local
 - Le sulfure de sélénium (Selsun®) 2 fois /semaines pendant 3 semaines
 - Les dérivés azolés (kétoconazole, Itraconazole, Econazole) en lotion, solution, gel moussant.
 - Le Cyclopirox (Mycoster®) en lotion, solution, gel moussant : 1 à 2 applications/jour pendant 2 à 3 semaines

Traitement

- **forme étendue, récidivante ou folliculaire :**
 - Traitement systémique : kétoconazole (Nizoral) : 200 mg/jour pendant 10 jours ou 400 mg/jour pendant 5 jours.
 - Traitement local : dérivés soufrés (Sélégel[®], Selsun[®]), antifongique topique (Kétoderm gel moussant monodose, Pévaryl[®] lotion)
- Les récurrences du Pityriasis versicolor sont très fréquentes.